

KC桌面——外资精译

Bernstein：美国医疗保健服务-专业药房培训总结

我们于上周三举办了一场关于专业药房的培训会，详细介绍了专业药房行业，包括其历史、宏观环境模式和竞争动态。本报告总结了本次网络研讨会的主要要点（[点击此处观看回放](#)，[点击此处查看幻灯片](#)）。

什么是专业药房——专业药房与传统零售药房不同，因为它专注于高成本、复杂的疗法，其中许多是生物制剂。尽管专业药物仅占处方量的3-4%，但它们却占药品总支出的一半以上，并且是医药市场中增长最快的领域之一。专业药物可能通过药房福利或医疗福利覆盖，约三分之二的支出通过药房福利发生，三分之一通过医疗福利发生，具体取决于疗法的给药方式。

商业模式——与管理药品福利和谈判返利的药品福利管理公司不同，专业药房通过配发药物和提供临床支持来产生收入，因此受监管和政策不确定性的影响较小。与传统零售药房相比，专业药房通常是集中式配送运营，强调患者支持服务，并大量涉及家庭配送。

专业药房宏观环境模式——尽管配发的处方数量相对较少，但专业药房能产生可观的收入，因为专业药物极其昂贵。盈利能力受规模、有限分销药物的获取渠道、生物类似药的采用、垂直整合以及支付方关系等因素驱动，最大的参与者（CVS、Accredo和Optum）主导市场，尽管日益增加的监管审查可能导致未来药品福利管理公司与专业药房分离。

我们将于美国东部时间7月30日上午11点继续我们的夏季培训系列，举办一场关于医疗补助管理式医疗的会议（[点击此处注册](#)）。本次会议将深入探讨管理式医疗补助行业，包括其历史、竞争对手、政策影响以及当前和未来展望。

我们将在美国东部时间8月20日上午11点举办另一场药品福利管理公司培训会（[点击此处注册](#)）。本次会议将聚焦新兴的透明药品福利管理公司模式，并参考自保雇主管理式医疗组织模式，以了解该业务的运作方式。

Bernstein公司表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社、Bernstein估计和分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予AGL与大市同步评级，CNC跑赢大盘评级，CI跑赢大盘评级，CVS跑赢大盘评级，ELV跑赢大盘评级，HCA与大市同步评级，HUM跑赢大盘评级，Molina跑赢大盘评级，UNH跑赢大盘评级。

详情：公司情况更新

有几个因素将专业药房与传统零售药房区分开来。专业药物更可能是生物制剂而非小分子疗法，并且通常治疗复杂、慢性或罕见疾病。这些药物通常成本高昂，促使一些药品福利管理公司将成本门槛纳入其专业药物的定义中。尽管专业药物仅占处方量的3-4%，但它们却占处方药总支出的一半以上。

与传统零售药房相比，专业药房能更好地控制药物的配发地点、配发流程的管理以及依从性的促进，以确保药物按处方使用。此外，许多专业药物需要特殊的处理、储存和给药方式。

图表1：什么是专业药房

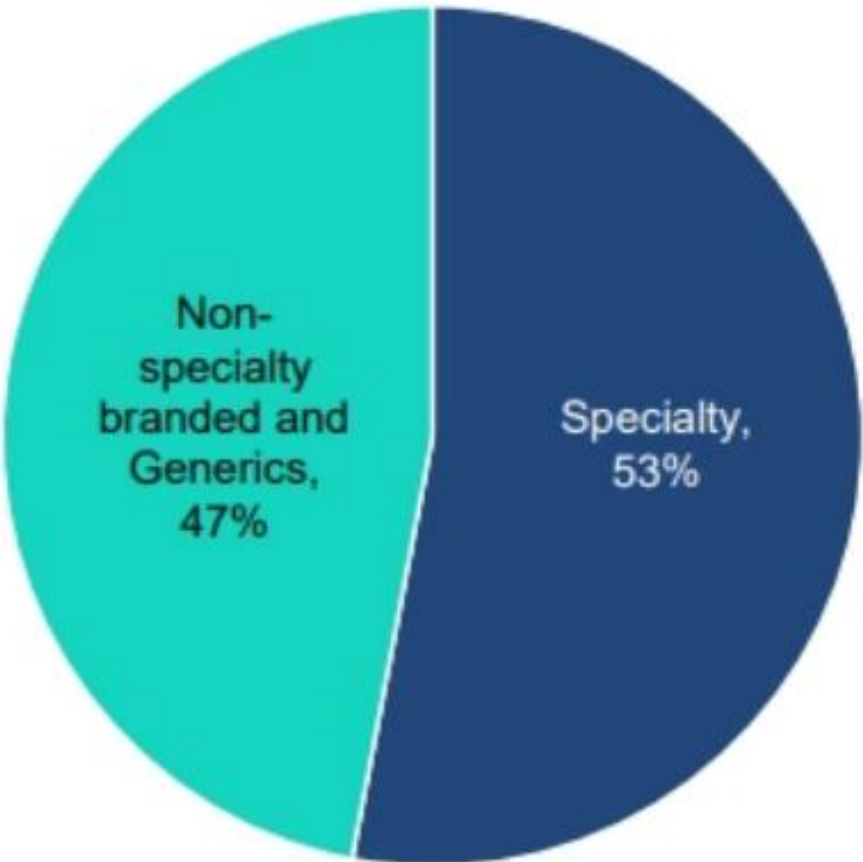
如今专业药物占药品总支出的一半以上

- 有多种定义该术语的方式
- 生物制剂与小分子药物

\- 比传统口服药物更复杂——处理、给药者、治疗复杂性

- 药品福利管理公司的定义包括成本

2025年处方药支出拆分



图表 1

来源：IQVIA、Bernstein分析

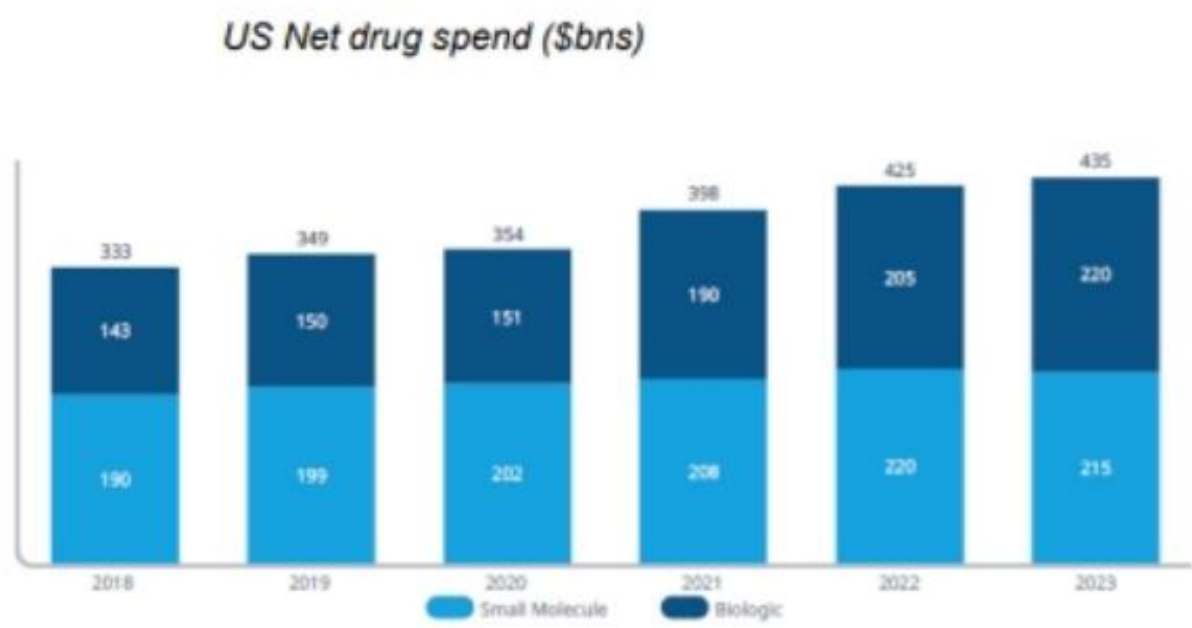
专业药房一直是医药市场中增长最快的领域之一。许多新推出的疗法，尤其是生物制剂，通过专业渠道进入市场。因此，专业药物支出的增长速度显著快于传统药物，近期成本趋势平均约为每年9%，而传统药物疗法为2.5%。

专业药物可能通过药房福利或医疗福利覆盖，具体取决于给药方式。药房福利下的专业药物通常是患者自行给药的药物，例如口服疗法和自行注射药物，而医疗福利下的专业药物通常由医疗专业人员在医生办公室、输液中心或医院环境中给药。

这些福利类别之间的支出驱动因素不同。在药房福利中，增长主要由随着疗法获得更广泛采用而增加的利用率驱动。在医疗福利中，支出增长更多由单位成本增加驱动。最近，生物类似药的引入有助于在几个治疗类别中缓和成本并降低每项索赔的成本。然而，由于这些药物的使用日益增加，专业药物支出继续上升。

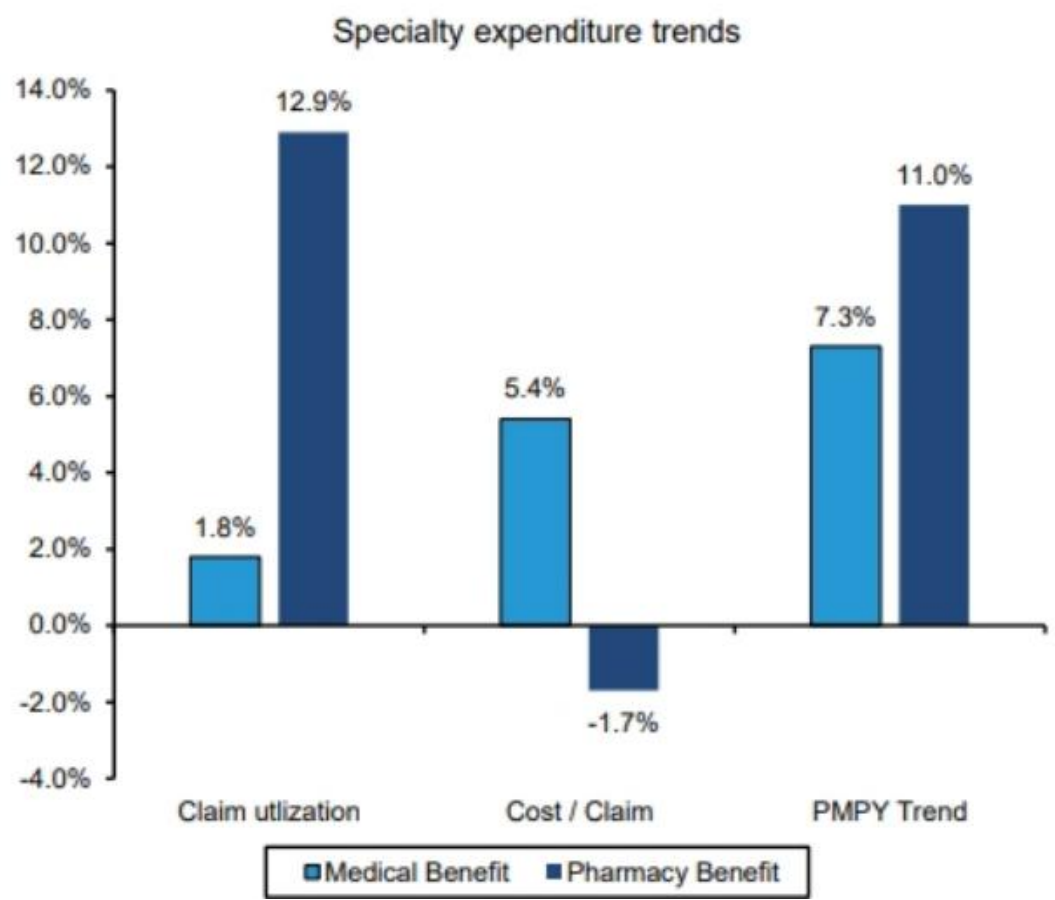
图表2：什么是专业药房——增长

近期专业药物成本趋势为9%，传统药物为2.5%



图表 2

来源：IQVIA、PSG、Bernstein分析 增长驱动因素——组合、价格上涨和处方数量增加



图表 3

在行业层面，约三分之一的专业药物支出由医疗福利覆盖，其余三分之二由药房福利覆盖。由于许多专业疗法由医疗专业人员在医生办公室、输液中心或医院中给药，因此相当一部分专业药物支出通过医疗福利而非药房福利覆盖。

雇主通常将医疗福利作为一个合同，然后为药房覆盖获得一个附加条款，该条款单独管理。医疗福利内的项目包括医生就诊、住院和医院环境中的药物给药。药房福利历史上是健康保险之上的额外覆盖，涵盖通过零售、邮购或专业药房配发的自行给药药物。

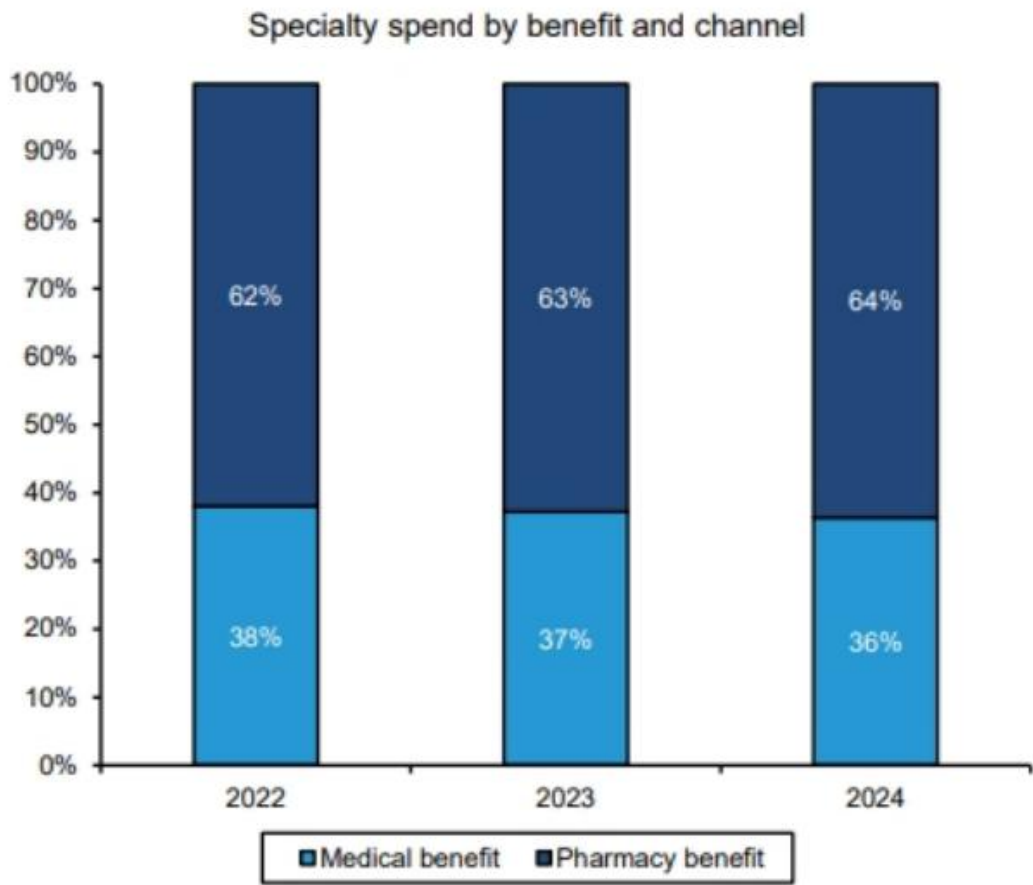
与传统零售处方不同，专业药物经常直接配送到患者家中。这种配送模式支持增强的临床监督和患者依从性。虽然一些专业药物通过CVS或沃尔格林等零售药房配发，但家庭配送仍然是常见的配送渠道，特别是对于自行给药的疗法。

2/5

治疗场所是专科药物的重要考量因素。由于许多疗法给药要求复杂，家庭输液环境中的专科药物使用率尤其高。在图表3中，报告的在医院内给药的比例低于我们的预期，这可能是因为隶属于医院的诊所被归类为"诊所"板块而非"医院"板块。

图表3：什么是专科药房

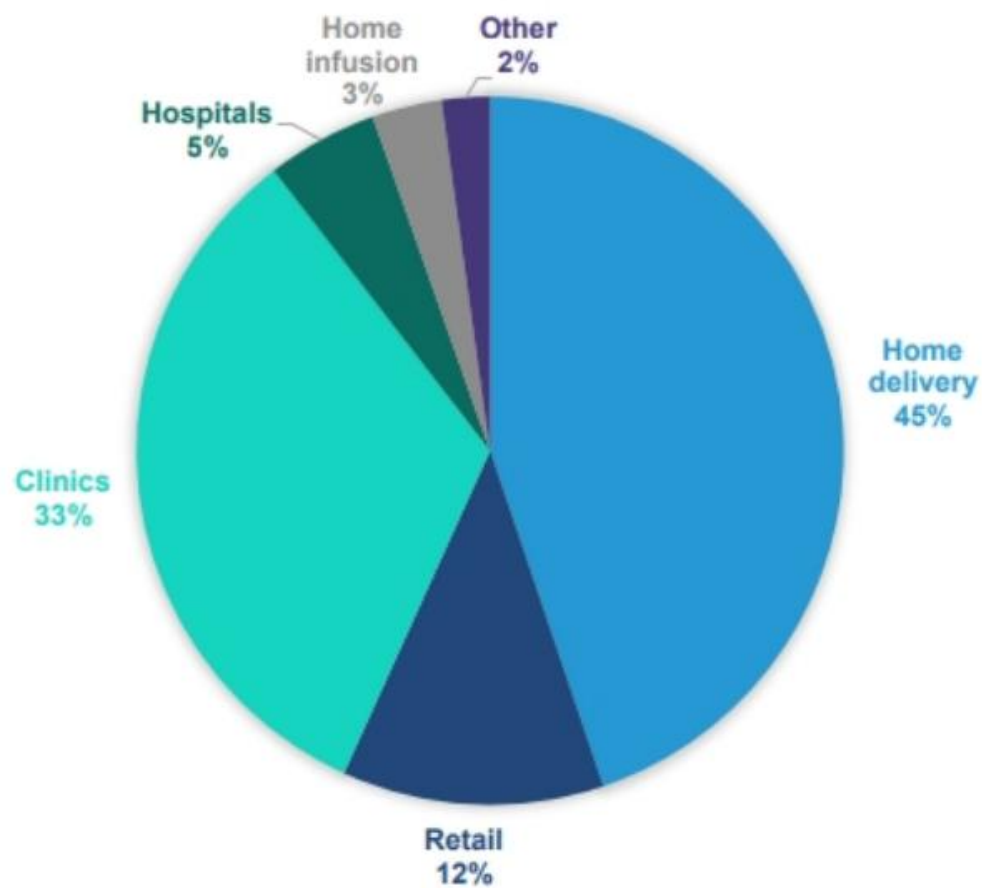
药品福利 vs 医疗福利



图表 4

给药或购买场所

资料来源：IQVIA、PSG、Bernstein分析



图表 5

专科药房通常可根据其提供的疗法类型和服务分为四个不同的类别。

传统专科药房主要专注于自我给药的疗法，包括口服药物和自行注射药物。其运营通常围绕一个大型配送中心集中进行，配备大量临床和支持人员，以教育患者并提高依从性。

罕见病与孤儿药遵循类似的运营模式，但专门针对罕见病和极罕见疾病的疗法。这些药物通常服务于小规模患者群体，且成本极高。

家庭输液提供在患者家中静脉给药的药物。

临床医生给药疗法由医疗专业人员在医生办公室、门诊诊所、输液中心或医院环境中提供。

图表4：专科药房模式

传统专科药房 - 口服药和自行注射药物

- 集中配药的规模与效率 • 配送物流 • 临床支持与专科状况支持 • 有限分销协议

罕见病与孤儿药

- 用于治疗影响小规模患者群体的疾病 • 为这些药物提供有限分销网络 • 为罕见病患者提供定制化服务 • 专门专家团队管理复杂疾病和特定疗法
- 协助患者应对罕见病相关挑战，如保险覆盖、宏观环境援助、护理协调
- 支持新型孤儿药的临床试验，为患者提供试验性药物 • 有限分销协议

家庭输液：公司情况更新

- 在无菌条件下制备药物 • 将耗材和设备配送至家中的物流 • 护理服务，对患者和护理人员进行给药培训 • 监测患者是否有任何副作用

- 药房、初级保健医生、护士、家庭健康机构之间的护理协调

临床医生给药

- 在医生办公室、输液中心或医院给药
- 确保特定剂量、处理及给药方法
- 与提供者协调、药物管理及遵守治疗方案

资料来源：Bernstein分析

药品供应链。专科药房通过配发医疗保健提供者开具的药物直接为患者服务。收入来源于药物的配发和给药，但药房必须支付药品采购成本。药房还需承担服务患者的运营成本，包括设施成本以及药剂师、护士和支持人员的专业费用。总体而言，这与零售药房并无不同。

药品福利管理机构（PBM）的运作更像管理式医疗组织。它们不配发药物，而是代表雇主管理处方药福利，并与药品制造商和药房谈判以控制总体药品支出。与PBM不同，专科药房不直接参与制造商的返利安排，而是主要通过配药赚取收入。

与更类似于保险业务的PBM不同，专科药房没有返利流入。

对于PBM，一个常见的问题是"为什么还需要PBM？"。PBM的作用是通过聚合来降低成本，类似于管理式医疗。相比之下，专科药房执行核心的医疗功能：配发药物和支持患者护理。对于这一角色的必要性几乎没有争议。因此，专科药房业务面临的政策不确定性低于PBM，后者的商业模式仍是监管和立法审查的持续对象。

图表5：专科药房 - 基本商业模式

资料来源：Bernstein分析

零售药房和专科药房在面向客户（"有地毯区"）和运营（"无地毯区"）功能上存在显著差异。在有地毯区，零售药房像传统的店面业务一样运营。位置很重要，因为它们依赖客流量，并通过店内商品产生收入，药房通常位于店铺后方。专科药房通常没有零售店面。它们作为配药中心运作，因此物理位置远不那么重要。通常，这些是长期用药，因此送货上门和使用集中仓库对于这种模式最为高效。

在无地毯区，零售药房高度自动化。数药片和装瓶通常自动化，药剂师在药物配发前进行最终验证。专科药房在其拣选、包装和发货中心也可能有自动化，但它们需要更高度度的个性化患者支持。除了配发药物，专科药房团队通常还管理预先授权、共付援助、报销和计费活动。

临床支持也是专科药房模式的核心组成部分。药剂师、护士和其他护理团队成员与患者密切合作，确保他们理解治疗方案、知道如何给药并坚持治疗。在专科药房中，药剂师处于"无地毯区"，他们可以远程配发药物并与患者沟通。

图表6：配药 - 有地毯区 vs 无地毯区

资料来源：Bernstein分析

零售药房和专科药房的客户获取方式差异很大。在零售药房中，客户获取由传统营销、品牌认知度和便利的店铺位置驱动。在专科药房中，患者获取受位置影响较小，更多受支付方网络、PBM关系、制造商合作伙伴关系和医生转诊影响。PBM的所有权可能是一个显著的竞争优势，因为PBM可能通过网络设计和降低自付费用来激励患者使用关联的专科药房。鉴于专科药物成本高昂，患者很少选择网络外药房，这使得大型PBM能够将处方量导向其自身的专科药房业务。

专业药房拥有有限分销药品（LDD）和独家分销药品（ED）。LDD 仅通过精选药房网络配发，而 ED 只能通过一家药房配发。获取有限分销产品的渠道可能是竞争优势的重要来源。

另一个关键要素是中心枢纽关系，这指的是由制造商支持的患者支持中心与一家或多家专业药房之间的工作关系。患者支持中心协助进行福利核实、预先授权、财务援助和病例管理，并常常影响哪些专业药房能获得处方量。医生参与也很重要，因为专业药房寻求与开处方的医生建立关系以获取业务。

规模专业药房提供了显著优势。像 CVS Specialty 和 Accredo 这样的大型组织受益于广泛的支付方网络、计划设计的灵活性、已建立的医生和中心枢纽关系，以及获取有限分销疗法的更大渠道。

有几个因素推动了专业药房客户获取的成功。强大的数据和报告能力对于提供患者结果和运营绩效的可见性越来越重要。配药速度是另一个关键指标。能够高效处理福利核实、预先授权和财务援助流程的药房，通常更有可能从医生那里获得未来的转诊，而中心枢纽可能将此指标作为决定哪家专业药房接收下一张处方的决定因素。强大的临床支持和药剂师数量也可能是差异化因素。最后，有竞争力的定价是另一个重要因素。

图 7：客户获取

来源：Bernstein 分析

在药房福利下，专业药物的报销要么按基准价格（如平均批发价）的折扣进行，要么按固定金额进行。药房还可能收取单独的配药费或管理费。

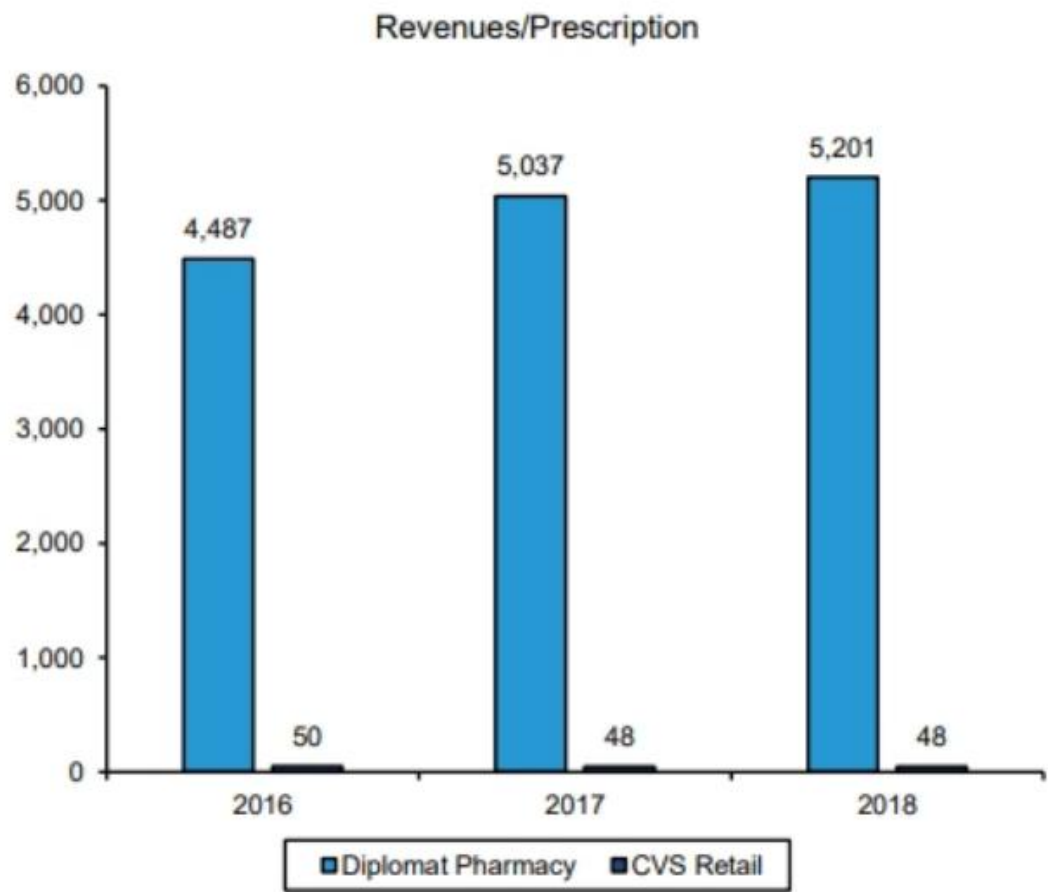
制造商返利通常不属于药房报销的一部分。返利归药房福利管理公司（PBM）所有，而非专业药房本身。这一区别对于同时拥有 PBM 和专业药房的垂直整合组织尤其重要。虽然专业药房不直接赚取返利，但整合的 PBM 可能能够通过处方集管理获取返利价值，然后将部分宏观环境利益纳入药品采购谈判中。因此，整合组织最终实现的宏观环境价值可能与独立药房不同，尽管返利本身并非在药房层面赚取。

对于在医疗福利下报销的药物，报销通常遵循“购买并开单”模式，提供方根据基准（如平均销售价格加加成，例如 ASP + 6%）获得付款。

专业药物比传统零售处方药贵得多。即使是相对低成本的专业疗法，价格也可能高达数千美元，而许多零售处方药的价格低于 50 美元。一些上市的专业产品每位患者每年的费用可能高达数十万美元。因此，专业药房可以从相对较小的处方量中产生可观的收入。

这可以通过 Diplomat Pharmacy 在被 Optum 收购前的每张处方收入来说明。如图 8 所示，平均每张专业处方约为 5,000 美元，而 CVS 的传统零售处方药约为 50 美元。

图 8：专业药房定价



图表 6

来源：公司报告，Bernstein分析

专业药房的毛利率可能有很大差异。商业、医疗保险和医疗补助合同的报销宏观环境性各不相同，品牌药和仿制药之间以及不同治疗类别的利润率也可能存在显著差异。一般来说，有限分销药品（LDD）和罕见病或孤儿药疗法往往产生更高的利润率。

规模是盈利能力的另一个重要驱动因素。规模较大的专业药房通常受益于更强的购买力、与制造商更牢固的关系以及更广泛的生物类似药获取渠道。与 PBM 的垂直整合也会影响专业药房的宏观环境效益。包括联邦贸易委员会（FTC）在内的批评者声称，垂直整合的 PBM 可能通过报销实践、网络设计或患者引导来偏袒其附属的专业药房。

垂直整合也可能影响定价和返利宏观环境性。PBM 可以向雇主提供有保证的折扣，同时在其网络内的药房之间不均匀地分配该折扣。例如，如果 PBM 承诺 25% 的折扣，它可能要求其附属专业药房提供 23% 的折扣，而非附属药房提供 27% 的折扣，从而使 PBM 能够实现承诺的总节省，同时可能使其自己的配药渠道受益。

不同专业药房类型的利润率也有所不同。传统专业药房的毛利率通常在约 3% 至 5% 的范围内，反映了更激烈的竞争和更广泛的网络参与。相比之下，专注于有限分销、罕见病或孤儿药疗法的药房，毛利率可能达到约 5% 至 7%，这得益于受限的分销网络和减少的竞争不确定性。

图 9：毛利率

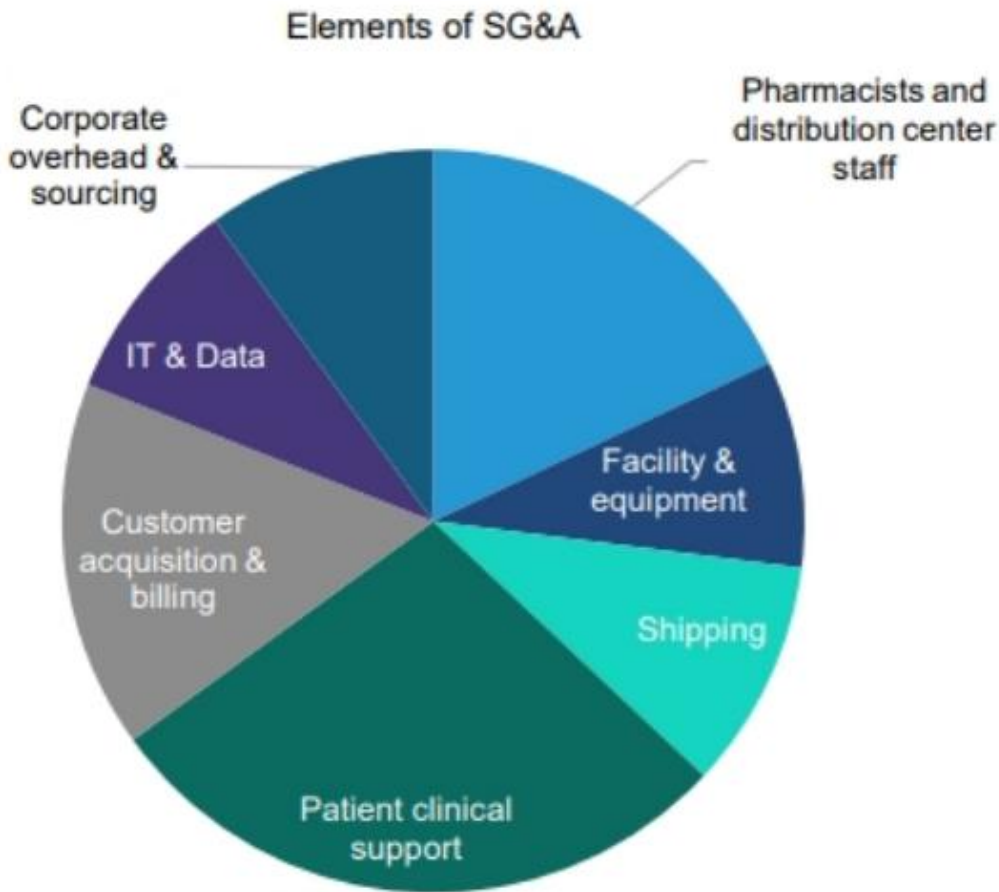
来源：Bernstein分析

除了药物本身的成本外，专业药房还承担着广泛的运营费用。根据粗略的经验法则，人工通常是最大的费用类别，约四分之一的成本归因于药剂师和配送中心员工，另外四分之一归因于患者临床支持。剩余的费用基础通常分布在运输和物流、设施和设备、信息技术和数据基础设施、客户获取以及公司管理费用上，各约占 10%。

报告的利润率也可能受到会计分类的影响。一些专业药房将某些面向患者的服务成本计入销售成本，而另一些则将这些费用报告为运营成本。例如，当 Diplomat Pharmacy 作为独立公司运营时，与直接患者服务相关的某些护理和运输费用被归类为销售成本而非销售、一般及管理费用。因此，在比较不同专业药房的毛利率和营业利润率时应谨慎，因为会计列报的差异可能会影响报告的财务数据。

图 10：关键财务杠杆 - 底线

注：其中某些项目可能包含在销售成本中 各要素规模的近似值



图表 7

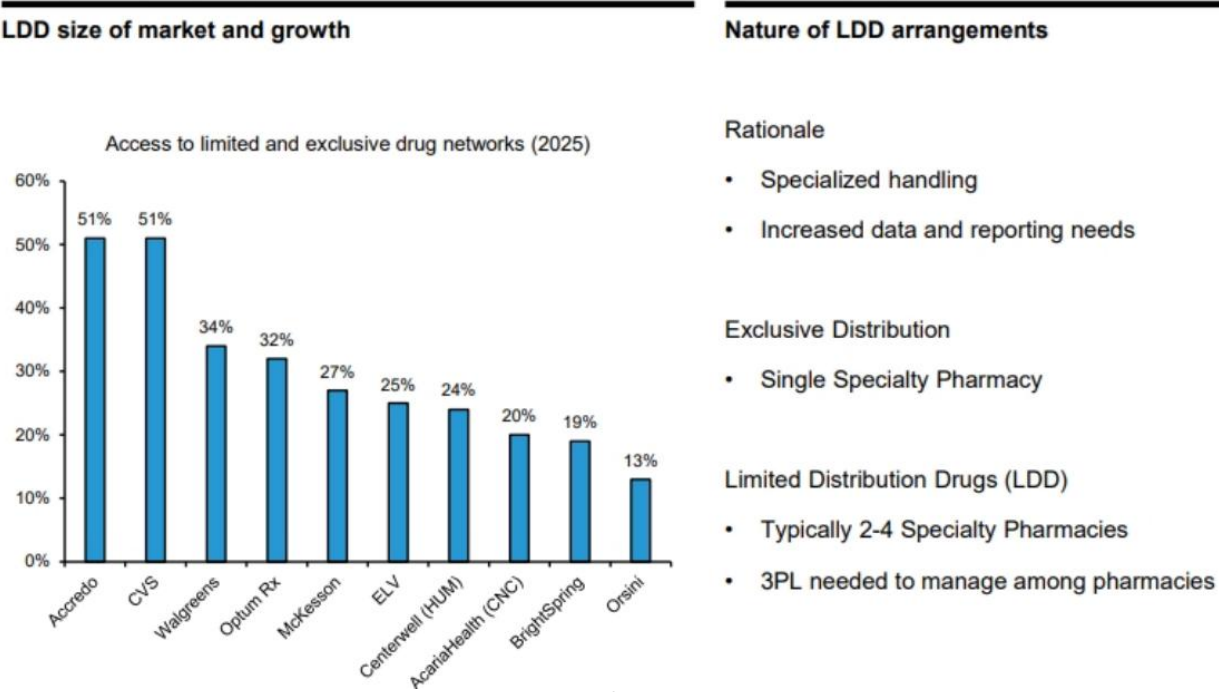
来源：Bernstein估计， Diplomat Pharmacy 公司文件

有限分销和独家分销药品在专业药房中日益普遍。这些分销模式通常倾向于要么是能够提供广泛患者覆盖和运营规模的大型专业药房，要么是在特定疾病领域拥有深厚专业知识的专业药房。如图表11所示，Accredo和CVS各自参与了略超过一半的有限和独家分销网络。同时，某些利基供应商已在特定治疗领域建立了强势地位。例如，BrightSpring在肿瘤学领域已占据重要地位，而像Panther Rare这样的高度专业化药房，其业务（即使不是全部）也大部分来自有限分销药品。

有限分销网络通常只包含两到四家专业药房。在许多情况下，网络中的一家药房被指定为第三方物流提供商，负责协调库存管理和分销活动，并因此获得额外补偿。

通过有限分销和独家分销渠道分销的药品通常是临床上最复杂的疗法之一。这些产品往往集中在肿瘤学、免疫学、罕见病/孤儿药、多发性硬化症以及其他需要强化患者管理和临床支持的专业类别。

图表11：有限分销药品



图表 8

来源：Drug Channels Institute，公司文件，Bernstein分析

专业药房中另一个重要的考量因素是生物类似药的增长。与通常为品牌药的有限分销和独家分销药品不同，生物类似药为专业药房创造了提高利润率的机会。随着患者从品牌药转向成本更低的生物类似药，其利润率预计将增加。从品牌药转向生物类似药时，美元利润预计将保持不变或有所改善。例如，如果一家药房从一种10,000美元的品牌药中获得500美元的毛利润，随后从一种5,000美元的生物类似药中获得同样的500美元利润，那么毛利率实际上翻了一番。

在实践中，药房通常从仿制药和生物类似药中获得的美元利润高于品牌药。我们的估计假设当品牌药被生物类似药取代时，利润保持美元对美元的中性，这可能偏于保守，并可能导致专业药房收益的上行空间。

生物类似药通常以比平均批发价低30%至50%的折扣上市，而品牌药的典型采购折扣约为25%。随着更多生物类似药竞争者进入市场，折扣可能变得更大，在某些情况下达到80%。如图表12所示，专利失效可能导致品牌药市场份额大幅流失和定价不确定性。

对于垂直整合的药品福利管理机构而言，由于它们有能力影响处方集设计，采用生物类似药的好处可能更容易被其获取。

图表12：生物类似药

- 截至2023年，生物类似药在可及市场中的采用率约为23%
- 仿制药的采用总体相当强劲，仿制药通常在12个月内达到70%的采用率
- 制造商竞争是品牌药折扣大小的主要驱动因素

不断增长的生物类似药机遇

美国专利失效的影响（十亿美元）



图表 9

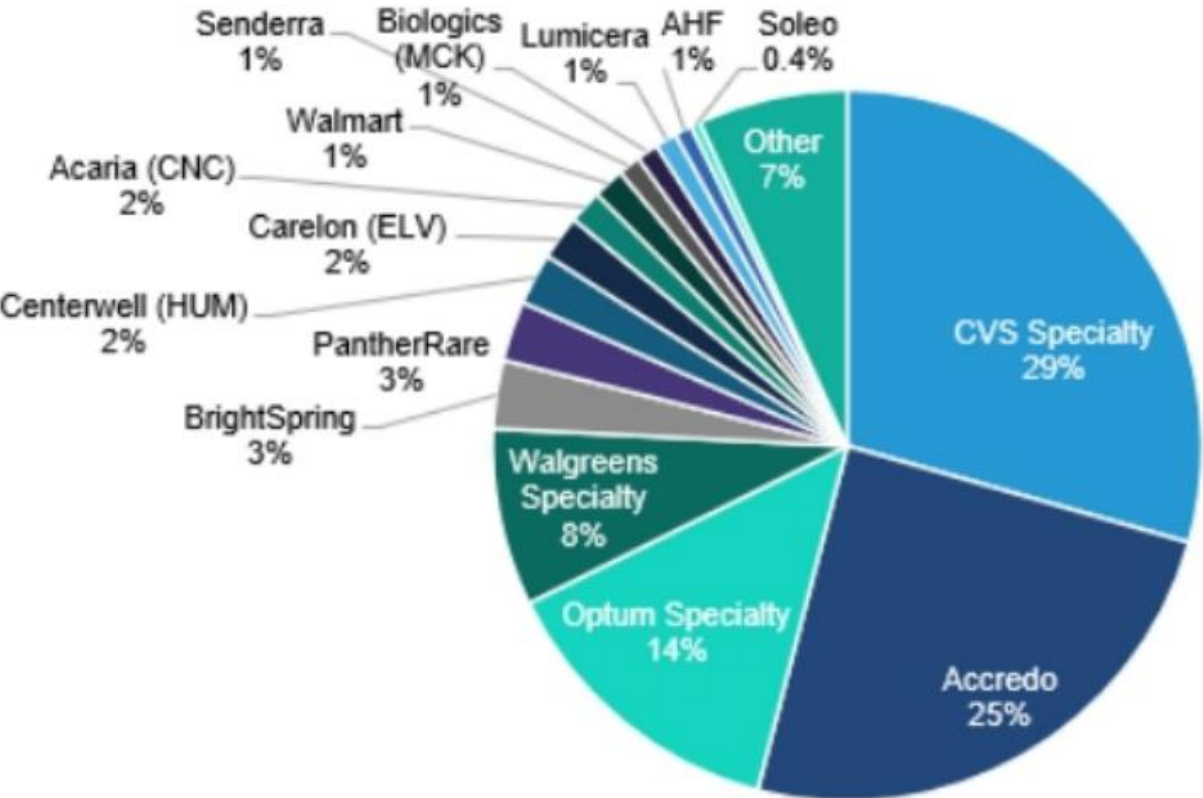
来源：IQVIA, CardinalHealth, Bernstein分析

CVS和Accredo合计占专业药房市场的一半以上，加上Optum，其合计份额增至近70%。Walgreens也仍然是一个重要的参与者，尽管其历史市场份额可能因其私有化转型相关的各种剥离和战略调整而夸大了其当前地位。展望未来，我们认为存在一种显著的可能性（或许在25%至35%的范围内），即当前对垂直整合的监管和政策审查最终可能导致药品福利管理机构与专业药房分离。在这种情况下，CVS、Accredo和Optum的专业药房可能会被分拆。一个更加分散的市场结构可能会削弱垂直整合组织目前享有的一些竞争优势，并为较小的参与者创造获得市场份额的机会。

图表13：主要专业药房参与者

主要参与者

- 三大药品福利管理机构是最大的专业药房 • 下一梯队参与者近期有所增长



图表 10

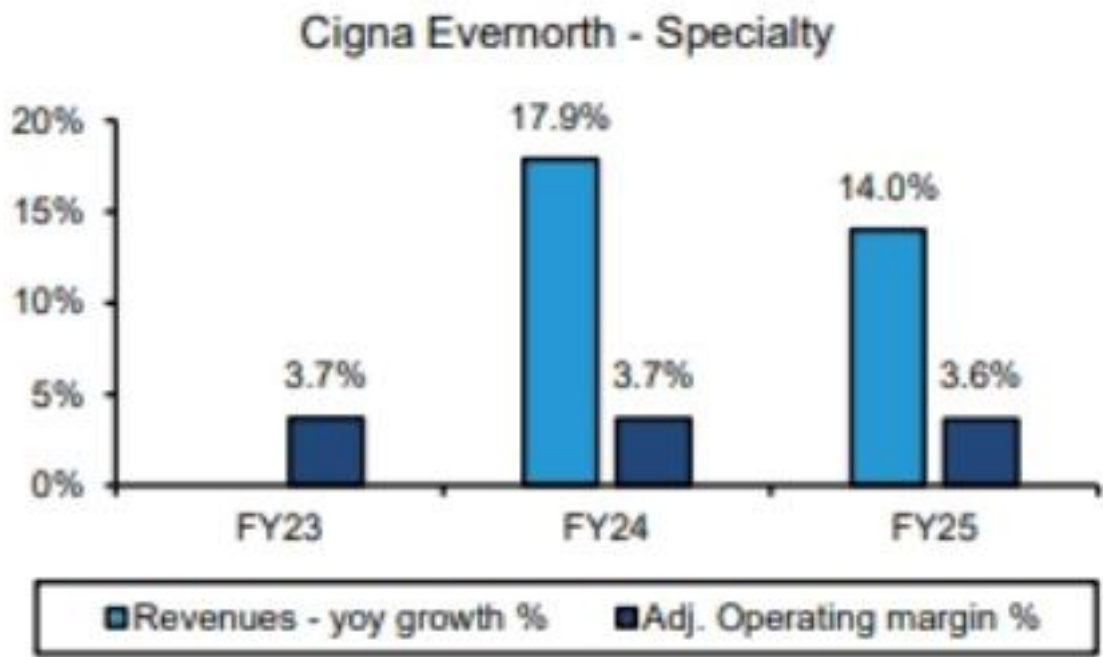
来源：Drug Channels Institute, 公司文件, Bernstein分析

Accredo和CVS是美国最大的两家专业药房。Accredo通过其临床能力实现差异化，雇佣了大约500名专业药剂师和600多名现场护士。该业务还受益于Evernorth平台内的相邻资产，包括专业分销领域的CuraScript和医院及340B药房市场的Shields Health Solutions。

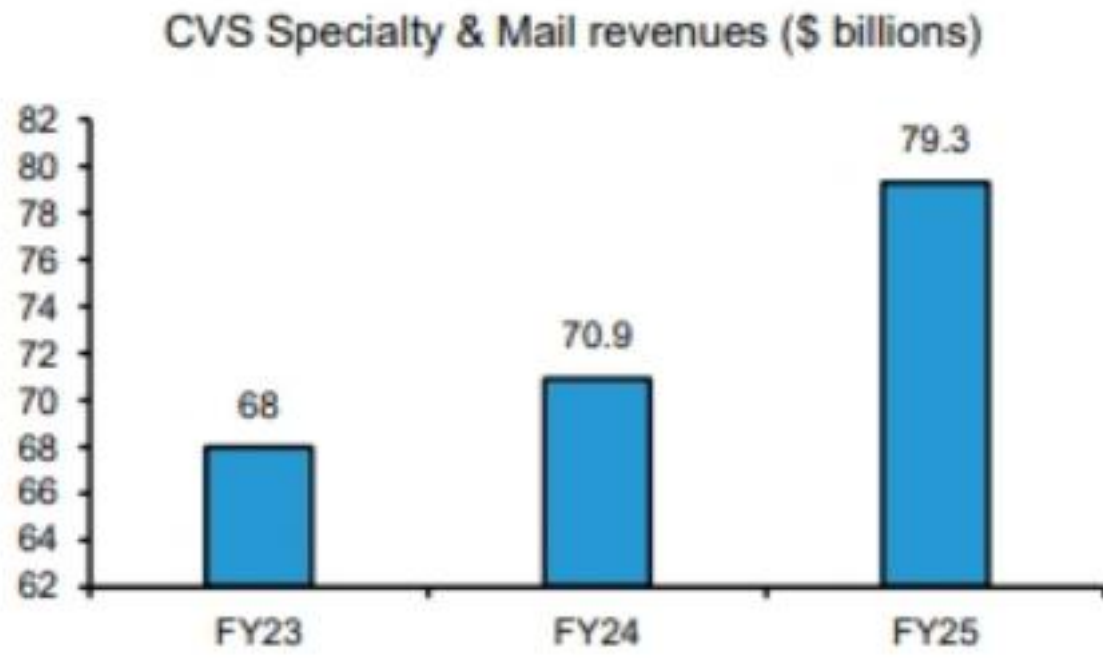
虽然Evernorth包含专业药房以外的业务，但Cigna历史上报告该板块的营业利润率约为3.5-4%。考虑到Evernorth内部的业务组合，专业药房毛利率范围约为3%至5%似乎是合理的。

CVS Health运营着市场上最大的专业药房平台。其对Coram的收购显著增强了其家庭输液能力。结合CVS Caremark和更广泛的CVS Health生态系统，CVS Specialty受益于巨大的规模、广泛的支付方关系以及对专业药品分销网络的广泛接入。

图表14：专业药房参与者



图表 11



图表 12

来源：公司报告，Bernstein分析与估计

Carelon通过收购（包括BioPlus、Kroger Specialty Pharmacy和Paragon Healthcare）稳步扩展其专业药房平台。这些交易拓宽了公司在专业配药和输液服务方面的能力。随着Carelon继续整合这些资产并利用Elevance Health的支付方关系，我们认为该专业药房业务最终可能达到约100-200亿美元的年收入规模。

OptumRx是市场上第三大专业药房提供商。该公司通过一系列收购（包括BrivoRx、Genoa Healthcare和Diplomat Pharmacy）建立了其地位。Brivo加强了Optum的专业药房能力，Genoa通过社区药房网络扩大了其在行为健康领域的影响力，而Diplomat则增加了专业配药方面的巨大规模。

图表15：专业药房参与者

来源：公司报告，Bernstein分析与估计

Humana的专业药房业务主要是通过有机增长而非大规模收购建立起来的。因此，其规模仍小于CVS、Accredo和Optum运营的专业药房平台。就其规模而言，该公司似乎拥有一支强大的临床团队，拥有600名药剂师。展望未来，一个有趣的战略问题是，Walgreens的新所有者最终是否会选择将公司部分专业药房业务变现。潜在买家可能包括大型综合医疗保健公司，如ELV、UNH或HUM。关键考量因素在于Walgreens的专业药房资产与其实体零售门店的整合程度，但我们认为其集中化的专业药房业务是易于出售的。

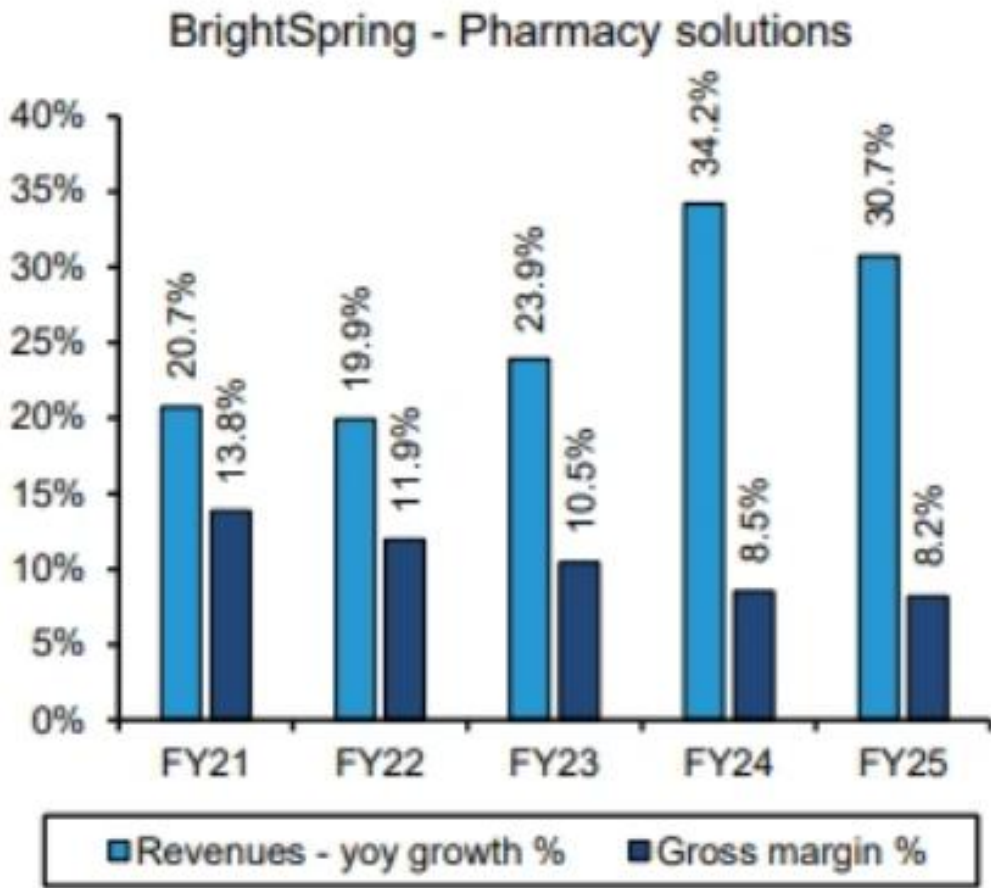
图表 16：专业药房参与者

来源：公司报告，Bernstein分析与预测

BrightSpring在以肿瘤学为重点的专业药房领域建立了强大的地位，并在近年来实现了显著增长，收入增长率通常在20%-30%之间。鉴于其专注于高度专业化的疗法，BrightSpring的毛利率往往高于更传统的专业药房，近年来已超过8%。

PANTHERx Rare是领先的罕见病专业药房之一，最近作为潜在的私募股权收购目标而备受关注。该公司完全专注于罕见和孤儿疗法，从而形成了高度专业化的临床和运营能力。Panther也是限量分销药物网络的常客，这反映了其在罕见病市场的声誉。虽然该公司的财务披露有限，但我们估计其年收入约为10亿美元。

图表 17：专业药房参与者



图表 13

来源：公司报告，Bernstein分析与预测

340B计划近年来显著增长，并已成为药房领域日益重要的组成部分。340B是一项允许符合条件的医院和医疗机构以折扣价购买药品的计划。这些实体以折扣价购买符合条件的药品，但按标准费率获得报销，从而保留差价。

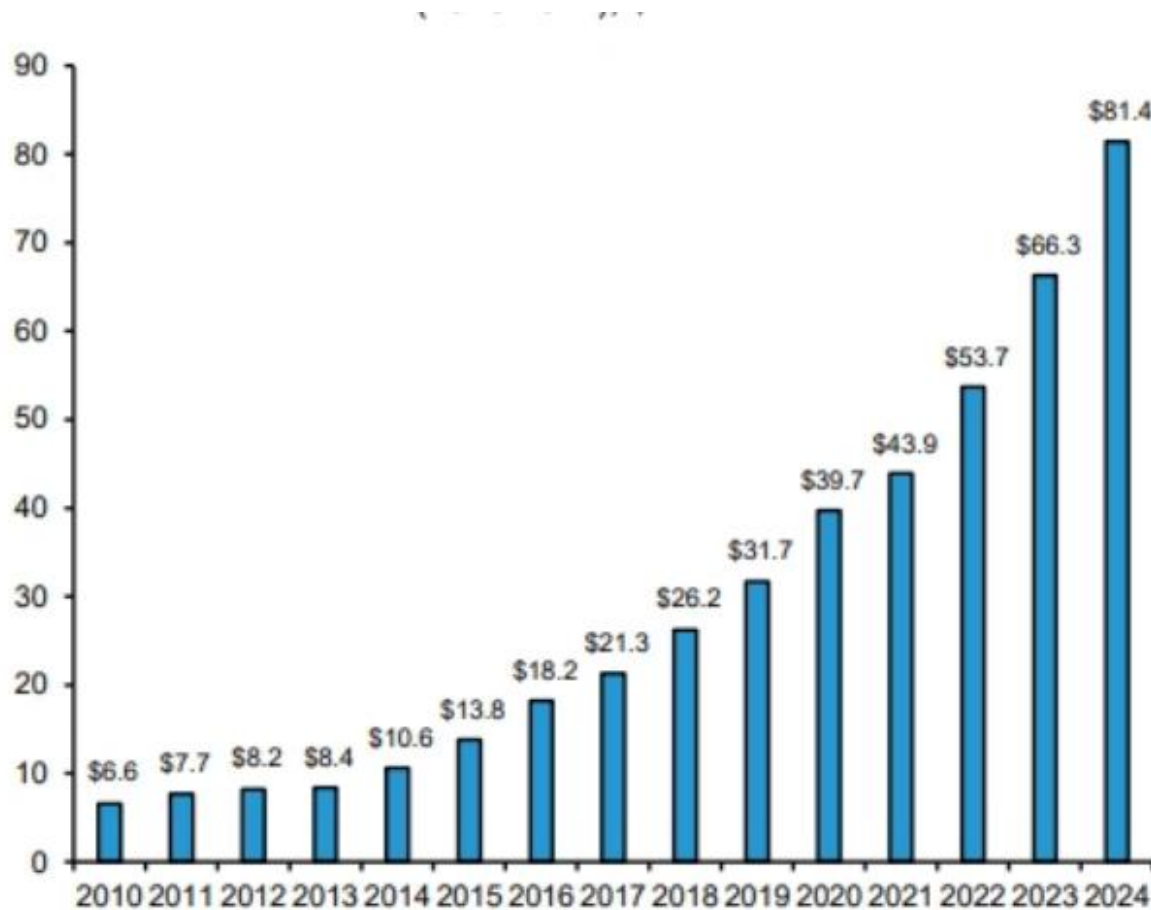
虽然零售药房历来通过合同药房安排对340B的敞口最大，但专业药房也通过与医院、医疗系统和其他覆盖实体的关系间接参与。因此，拥有强大医院和医疗系统药房平台的公司，其340B市场的敞口可能会随着时间的推移而增加。特别是，OptumRx和Express Scripts（通过其对Shields Health Solutions的研究）将增加对340B的敞口。

由于其快速增长，340B计划已成为潜在政策变革的目标。对于2027日历年，CMS提议将340B采购药品的报销率降至ASP - 33.4%，这将远低于当前ASP + 6%的计算方法。

图表 18：340B计划

340B背景介绍

- \- 340B要求参与Medicaid和Medicare B部分的制造商以折扣价向符合条件的安全网实体出售符合条件的门诊药品，以便这些实体能够节省稀缺资源并扩大服务范围。
 - \- 符合条件的参与者包括六类非营利或公立医院，以及联邦受助机构，如FQHC、Ryan White诊所和其他指定的安全网提供者。
 - \- 覆盖实体通常以340B价格购买药品，并按标准费率由保险公司报销，从而保留差价。对于许多零售药品，Medicaid按服务收费是一个例外。
 - \- 覆盖实体可以通过内部药房或合同药房（包括专业药房）配药，以覆盖患者并在符合条件的门诊处方上获得340B折扣。
- 该计划受到审查的部分原因是其快速增长



图表 14

来源：CBO，Bernstein分析

虽然340B本身不太可能成为专业药房的长期主要增长驱动力，但它对于服务医院和临床医生管理疗法的药房来说仍然是一项重要能力。在这些市场取得成功通常取决于与医院和医疗系统建立牢固的关系，包括帮助他们管理专业药房运营、支持340B计划以及提供行政和临床服务。与医院有效合作的能力可能成为重要的竞争差异化因素。

与340B注册医院签约的药房数量在过去五年中增加了一倍多。如图表19所示，CVS在与覆盖实体的合同中拥有最高的市场份额（占市场的32%），其次是Walgreens（20%）。它们广泛的零售网络和广阔的地理覆盖可能有助于其领先地位，使其成为医院和其他覆盖实体的有吸引力的合作伙伴。

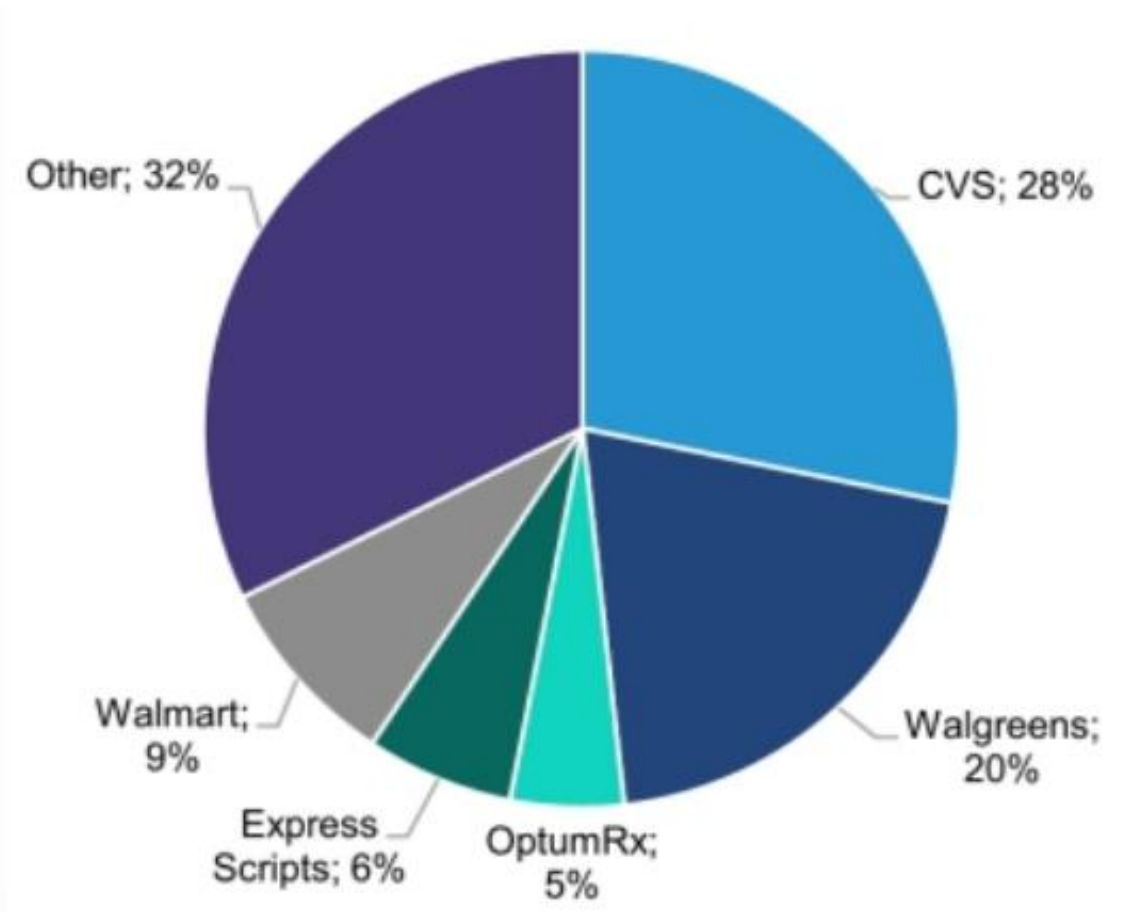
图表 19：专业药房在340B中的作用

- \- 340B注册医院和受助机构可以选择通过内部药房或通过合同药房的合同安排，向患者配发340B药品。
- \- 截至2021年，HRSA的药房事务信息系统数据库中有超过145,000家注册合同药房。
- \- 截至2026年7月，根据HRSA药房事务办公室的数据库，有超过330,000家注册参与的合作药房。

来源：药房事务办公室，Bernstein分析

即将举行的2026年宣讲会

Medicaid管理式医疗 7月30日 东部时间上午11点 [点击此处注册](#)



图表 15

按药房划分的合同药房/覆盖实体关系百分比（2026年7月）

PBM与雇主自保 8月20日 东部时间上午11点 [点击此处注册](#)

OptumInsights 8月27日 东部时间上午11点 [点击此处注册](#)